ชี้แจงแนวปฏิบัติ วัคซีน PCV ตามคำแนะนำกรมควบคุมโรค

ถาม–ตอบ ประเด็นจากพื้นที่ วัคซีน PCV

คำถามที่พบบ่อย ตอบตามแนวทางมาตรฐาน กรมควบคุมโรค และตัวบทกฎหมาย

ถาม ฉีด 3 เข็มในวันเดียว (อายุ 2 เดือน) ปลอดภัยไหม

✅ **ปลอดภัย และไม่ลดประสิทธิภาพวัคซีน**

- ฉีดคนละตำแหน่ง ถ้าต้นขาเดียวกัน ห่างกันอย่างน้อย 1 นิ้ว
- อาการที่พบ ปวด บวม แดง หายเองใน 2–3 วัน

📖 คำแนะนำ กรมควบคุมโรค ต.ค. 2569

ถาม แยกวันฉีด PCV ได้ไหม

✅ **ตารางมาตรฐาน ฉีด PCV พร้อมวัคซีน ตามแผนงานในนัดเดียวกัน**

⛔ **การเลื่อนเข็ม ที่ถึงกำหนด ไม่ใช่ตารางมาตรฐาน เด็กขาดภูมิคุ้มกัน นานขึ้น**

- ผู้ปกครองมีสิทธิ ปฏิเสธ ให้บันทึกไว้ แล้วให้ตาม ตาราง Catch-up

📖 คำแนะนำ กรมควบคุมโรค ต.ค. 2569 · พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ม.8

ถาม ต้องมี Consent Form ไหม

✅ **กฎหมายบังคับ ให้แจ้งข้อมูล อย่างเพียงพอ ก่อนให้บริการ**

- ไม่ได้บังคับ รูปแบบหนังสือ แต่ควรบันทึก การแจ้งข้อมูลในเวชระเบียน

⛔ **ผู้ปกครองปฏิเสธ จะให้บริการนั้นมิได้**

📖 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ม.8

ถาม PCV เป็นวัคซีนใหม่ใช่ไหม

✅ **ไม่ใช่วัคซีนใหม่ เพียงเพิ่งบรรจุ ในแผนงาน EPI**

- เป็นสิทธิประโยชน์ ตามประกาศ กก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) มีผล 1 ต.ค. 2569
- เด็กอายุ 2, 4 และ 12 เดือน รวม 3 ครั้ง

📖 ประกาศ กก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) 2569

ถาม ใครเป็นผู้ฉีดวัคซีนได้

✅ **พยาบาลวิชาชีพ ชั้นหนึ่ง ที่มีใบอนุญาต**

✅ **ผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน ตามเงื่อนไขข้อบังคับสภาฯ 2563**

⛔ **ผู้ไม่มีใบอนุญาต ห้ามฉีดยา หรือสารใด ๆ เข้าร่างกาย**

📖 พ.ร.บ.พยาบาลฯ ม.4, ม.27 · ข้อบังคับสภาการพยาบาล 2564 · สภาการสาธารณสุขชุมชน 2563

ถาม ถ้าเกิด AEFI จะเป็นอย่างไร

- รายงานและสอบสวน ตามแนวทาง เฝ้าระวัง AEFI กองระบาดวิทยา

✅ **ผู้เสียหาย ได้เงินช่วยเหลือ เบื้องต้น ไม่ต้องรอ พิสูจน์ถูกผิด**

✅ **ทำในหน้าที่ หน่วยงานรัฐ รับผิดแทน เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะจงใจ หรือประมาทร้ายแรง**

📖 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ม.41–42 · พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ ม.5, ม.8

เอกสารต้นฉบับ

สแกน QR เพื่อเปิดอ่าน และตรวจสอบการตีความ

- คำแนะนำ PCV กรมควบคุมโรค 2569
- ประกาศ กก. (ฉบับที่ 11) 2569
- พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลฯ 2528
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550
- ข้อบังคับ ม.41 (ฉบับที่ 3) 2564
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 2539

ฉีดพร้อมกัน หรือแยกนัด? ผลดี ผลเสีย และแนวทาง

ฉีดแยกตำแหน่ง ไม่แยกนัด ลดการตกหล่น ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

✅ ฉีดพร้อมกันในนัดเดิม ตารางมาตรฐาน

- ✅ เด็กได้ภูมิคุ้มกันเร็ว ตรงช่วงอายุ ที่เสี่ยงโรคสูงสุด
- ✅ มารับบริการน้อยครั้ง ลดภาระผู้ปกครอง
- ✅ ลดโอกาสตกหล่น และพลาดนัด
- ✅ ตรงตามแนวทาง มีหลักฐานทางวิชาการ รองรับ (WHO, ACIP)
- ✅ สอดคล้องแนวทาง มาตรฐาน เมื่อมี การสอบสวน AEFI

⚠️ แยกนัดฉีด ไม่ใช่ตารางมาตรฐาน

- ⚠️ เด็กเปิดช่องว่าง ไม่มีภูมิคุ้มกัน นานขึ้น
- ⚠️ ผู้ปกครองต้องพาเด็ก มาหลายครั้ง
- ⚠️ เสี่ยงขาดนัด ได้รับวัคซีนไม่ครบชุด
- ⚠️ หน่วยบริการ ภาระงานและนัดเพิ่ม
- ⚠️ หากไม่เป็นไปตามแนวทาง ถูกพิจารณาว่า ไม่ได้มาตรฐาน

📋 แนวทางการให้บริการ 5 ขั้น

1 🩺 ก่อนฉีด

คัดกรองสุขภาพ
แจ้งข้อมูลวัคซีน
ประโยชน์
และอาการที่อาจพบ

2 💉 ขณะฉีด

PCV + IPV
ต้นขาข้างหนึ่ง ห่าง ≥
1 นิ้ว · DTP-HB-Hib
อีกข้าง · Rota
ทางปาก

3 ⏱️ หลังฉีด

สังเกตอาการ
30 นาที
แนะนำการดูแล
และอาการ
ที่ต้องกลับมา

4 🗂️ บันทึก

HIS
ของหน่วยบริการ →
HDC และสมุดสีชมพู
นัดเข็มถัดไป

5 🔔 กรณีพิเศษ

ผู้ปกครองปฏิเสธ
ลงนามไว้ · เกิด AEFI
รายงานระบบ
AEFI-DDC

🗓️ กำหนดการ PCV (2+1)

เด็กเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2568

2 เดือน	PCV1 + DTP-HB-Hib1 + IPV1 + Rota1
4 เดือน	PCV2 + DTP-HB-Hib2 + IPV2 + Rota2
12 เดือน	PCV3 (กระตุ้น) + LAJE1

เด็กมาล่าช้า: นับเข็มต่อ ให้ทันที เมื่อครบระยะห่างขั้นต่ำ (เริ่มก่อน 12 เดือน ≥ 4 สัปดาห์ · เริ่ม 12–23 เดือน ให้ 2 ครั้ง ห่าง ≥ 8 สัปดาห์)

📚 เอกสารต้นฉบับ

สแกน QR เพื่อเปิดอ่าน และตรวจสอบการตีความ

- คำแนะนำ PCV กรมควบคุมโรค 2569
- ประกาศ กก. (ฉบับที่ 11) 2569
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 ม.8

สรุปตัวบทกฎหมาย **การให้บริการวัคซีน PCV** แผ่นที่ 3/8

ประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีวัคซีน PCV

ประกาศ 2 ฉบับ ออกตาม ม.5 วรรคสาม และ ม.18 (3) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ตรวจสอบตัวบท
9 พ.ย. 2569

สาระสำคัญของตัวบท

ฉบับแรก
ลงวันที่ 17 เม.ย. 69

ประกาศกรณีบริการวัคซีน PCV พ.ศ. 2569

ราชกิจจานุเบกษา 30 เม.ย. 2569 กำหนดให้ PCV เป็นบริการที่จำเป็น ต่อสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2569 และรับรองบริการที่ให้ไปแล้ว ตั้งแต่ 2 มี.ค. 2569

ฉบับที่ 11
ลงวันที่ 24 มิ.ย. 69

เพิ่ม PCV ในชุดสิทธิประโยชน์ ต่อเนื่อง

ราชกิจจานุเบกษา 20 ก.ค. 2569 มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2569 เพิ่มลำดับ 28 กลุ่มเด็กเล็ก 0–5 ปี

ลำดับ 28
กิจกรรม

ครั้งที่ 1 อายุ 2 เดือน · ครั้งที่ 2 อายุ 4 เดือน · ครั้งที่ 3 อายุ 12 เดือน

กลุ่มเป้าหมาย เด็กอายุ 2 เดือน ถึง 12 เดือน ความถี่ 3 ครั้ง

ความหมายต่องานวัคซีน PCV

- PCV เป็น สิทธิของเด็กไทย ที่หน่วยบริการ ต้องจัดให้
- กำหนดการ 2, 4, 12 เดือน เป็นกำหนดการ ตามชุดสิทธิประโยชน์
- เป็นบริการ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ภายใต้กองทุนฯ

ข้อควรระวัง

- ประกาศกำหนด อายุและจำนวนครั้ง ไม่ได้กำหนดเรื่อง แยกนัดหรือ Consent
- วิธีให้บริการ ยึดคำแนะนำ กรมควบคุมโรค

สรุปสั้น · สแกน QR เพื่อเปิดเอกสารต้นฉบับ

PCV คือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย หน้าที่ของหน่วยบริการ คือให้เด็กได้รับครบ 3 ครั้ง ตรงตามกำหนด

ประกาศ กก. กรณี PCV 2569

ประกาศ กก. (ฉบับที่ 11) 2569

สรุปตัวบทกฎหมาย **การให้บริการวัคซีน PCV** แผ่นที่ 4/8

ผู้มีอำนาจให้วัคซีน ตามกฎหมายวิชาชีพ

พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลฯ 2528 · ข้อบังคับสภาการพยาบาล 2564 · ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน 2563

ตรวจสอบตัวบท 9 พ.ย. 2569

สาระสำคัญของตัวบท

ม.4, ม.27 พ.ร.บ.พยาบาล

การให้ภูมิคุ้มกันโรค เป็นการประกอบวิชาชีพ การพยาบาล

ผู้ไม่มีใบอนุญาต ห้ามกระทำ ยกเว้น (4) ผู้ที่หน่วยงานรัฐ มอบหมาย ในความควบคุม ของพยาบาล และ (5) ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ตามกฎหมายวิชาชีพนั้น · ฝ่าฝืน ม.46 จำคุก ≤ 2 ปี หรือปรับ ≤ 20,000 บาท

ข้อ 10, 14 สภาการพยาบาล 2564

พยาบาลชั้นหนึ่ง ให้ภูมิคุ้มกันโรค แก่ทารกและเด็กได้

> “ในการให้ภูมิคุ้มกันโรค ต้องปฏิบัติตาม แนวทางการให้ ภูมิคุ้มกันโรค ที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด”

ข้อ 15, 35 สภาการพยาบาล 2564

บันทึกและเก็บไว้ 5 ปี · ชั้นสอง แนะนำและติดตาม

ต้องบันทึก ประวัติ การให้บริการ วันเวลา ชื่อผู้ให้บริการ ตามความเป็นจริง เก็บไว้ 5 ปี ส่วนพยาบาลชั้นสอง ให้คำแนะนำ และติดตาม ให้มารับภูมิคุ้มกันโรค

ข้อ 5, 13 สภา สสช. 2563

ผู้ประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน

> “ให้กระทำการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรค ตามแนวทางที่ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศกำหนด”

ความหมายต่องานวัคซีน PCV

- พยาบาลวิชาชีพ ชั้นหนึ่ง และนักสาธารณสุข ที่มีใบอนุญาต ให้วัคซีนได้
- ทั้งสองสภา บังคับให้ทำตาม แนวทางกระทรวง สาธารณสุข การฉีดตาม คำแนะนำ กรมควบคุมโรค จึงเป็นหน้าที่ ตามวิชาชีพ
- บันทึกการให้บริการ ตามจริง และเก็บไว้ เป็นหลักฐาน

ข้อควรระวัง

- ผู้ไม่มีใบอนุญาต หรือพยาบาลชั้นสอง ไม่ฉีดวัคซีนเอง
- การปรับตารางนัด นอกแนวทาง กระทรวง อาจขัดข้อ 14 (สภาการพยาบาล) และข้อ 5 (สภา สสช.)

สรุปสั้น · สแกน QR เพื่อเปิดเอกสารต้นฉบับ

ผู้ให้วัคซีนต้องมีใบอนุญาตและให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบังคับไว้ชัดเจน

พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลฯ 2528

ข้อบังคับสภาการพยาบาล 2564

ข้อบังคับ สภา สสช. 2563

สรุปตัวบทกฎหมาย **การให้บริการวัคซีน PCV** แผ่นที่ 5/8

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 8

สิทธิรับรู้ข้อมูล และตัดสินใจรับหรือไม่รับบริการ

ตรวจสอบตัวบท
9 พ.ย. 2569

สาระสำคัญของตัวบท

ม.8 วรรคหนึ่ง

แจ้งข้อมูลให้เพียงพอ ต่อการตัดสินใจ

บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องแจ้งข้อมูล ด้านสุขภาพ ให้ผู้รับบริการทราบ อย่างเพียงพอ ที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ

> “ในกรณีที่ผู้รับบริการ ปฏิเสธไม่รับบริการใด จะให้บริการนั้นมิได้”

ม.8 วรรคสอง

ผู้รับบริการปกปิด หรือแจ้งเท็จ

ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหาย เว้นแต่ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง

ม.8 วรรคสาม

ข้อยกเว้น

(1) อยู่ในภาวะ เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และจำเป็นต้องช่วยเหลือ เร่งด่วน (2) ไม่อยู่ในฐานะรับทราบข้อมูล และไม่อาจแจ้ง ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ได้

ความหมายต่องานวัคซีน PCV

- อธิบายผู้ปกครอง ถึงประโยชน์ อาการที่อาจพบ และการฉีดหลายเข็ม ในวันเดียว
- ผู้ปกครองตัดสินใจ แทนเด็ก ในฐานะ ผู้แทนโดยชอบธรรม
- ผู้ปกครองปฏิเสธ งดฉีด บันทึก และให้ลงนามไว้ เป็นหลักฐาน

ข้อควรระวัง

- ม.8 ไม่ได้กำหนด ให้ต้องทำเป็นหนังสือ แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่า ได้แจ้งข้อมูลแล้ว จึงควรบันทึก ในเวชระเบียน
- หนังสือยินยอม ที่กฎหมายบังคับ ตาม ม.9 ใช้กับ การทดลองในงานวิจัย

สรุปสั้น · สแกน QR เพื่อเปิดเอกสารต้นฉบับ

แจ้งข้อมูลครบ ผู้ปกครองตัดสินใจเอง ถ้าปฏิเสธต้องเคารพ และบันทึกไว้ทุกครั้ง

พ.ร.บ.สุขภาพ แห่งชาติ 2550

สรุปตัวบทกฎหมาย **การให้บริการวัคซีน PCV** แผ่นที่ 6/8

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41–42

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อผู้รับบริการได้รับความเสียหาย

ตรวจสอบตัวบท 9 พ.ย. 2569

สาระสำคัญของตัวบท

ม.41 เงินช่วยเหลือ

กันเงิน ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินที่จ่าย ให้หน่วยบริการ

เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อผู้รับบริการ ได้รับความเสียหาย จากการรักษาพยาบาล ของหน่วยบริการ

> “หาผู้กระทำผิดมิได้ หรือหาผู้กระทำผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหาย ภายในระยะเวลาอันสมควร”

ข้อ 7 ข้อบังคับ ฉ.3 2564

ยื่นคำร้อง ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ ทราบความเสียหาย

ผู้เสียหาย ทายาท ผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการ ยื่นได้ (ข้อบังคับ กก. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ราชกิจจาฯ 2 มิ.ย. 2564) · 2 ปี มาจาก ข้อบังคับ ไม่ได้อยู่ใน ตัว ม.41

ม.42 ไล่เบี้ย

สปสช. ไล่เบี้ยได้ เฉพาะเมื่อ หาผู้กระทำผิดได้

เมื่อจ่ายเงินช่วยเหลือ ไปแล้ว สำนักงาน มีสิทธิไล่เบี้ย เอาแก่ผู้กระทำผิด

ข้อ 76–77 ประกาศ กก. ปี 2570

ครอบคลุม บริการป้องกันโรค และผู้ให้บริการ

ข้อ 76 ผู้มีสิทธิ ที่ได้รับผลกระทบ จากบริการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ได้รับตาม ม.41 · ข้อ 77 ผู้ให้บริการ ที่ได้รับความเสียหาย ก็มีเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น

ความหมายต่องานวัคซีน PCV

- ยื่นคำร้องได้ที่ หน่วยบริการ ศูนย์ ม.50 (5) สสจ. หรือ สปสช. เขต
- เยียวยาเบื้องต้น โดยเร็ว ไม่ต้องรอ ผลการพิสูจน์ ถูกผิด ใช้ได้ทั้ง รพ.สต. สังกัด สธ. และถ่ายโอน

เกิดความเสียหาย หลังรับบริการ → ยื่นคำร้อง: ผู้เสียหาย ทายาท ผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการ → คณะอนุกรรมการ พิจารณาตาม ข้อบังคับ → จ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้น

ข้อควรระวัง

- ม.41 ไม่ใช่ช่องทาง ร้องเรียนเพื่อลงโทษ เจ้าหน้าที่ และไม่ใช่ เงินชดเชย
- การไล่เบี้ย ตาม ม.42 กับเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องพิจารณาร่วมกับ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 2539

สรุปสั้น · สแกน QR เพื่อเปิดเอกสารต้นฉบับ

มาตรา 41 คุ้มครองผู้รับบริการให้ได้รับการเยียวยาเร็ว และลดการฟ้องร้อง ไม่ได้มีไว้เอาผิดผู้ให้บริการ

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ 2545 | ข้อบังคับ ม.41 (ฉบับที่ 3) 2564 | ประกาศ กก. ปีงบประมาณ 2570

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ตรวจสอบตัวบท
9 พ.ย. 2569

สาระสำคัญของตัวบท

ม.5 ในหน้าที่

หน่วยงานรัฐ รับผิดต่อผู้เสียหาย

ละเมิดที่เจ้าหน้าที่ กระทำในการปฏิบัติหน้าที่

> “ผู้เสียหายอาจฟ้อง หน่วยงานของรัฐ ได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้”

ม.6 นอกหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับผิด เป็นการเฉพาะตัว

ถ้าการกระทำ มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหาย ฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

ม.8 ไล่เบี้ย

เรียกคืนจากเจ้าหน้าที่ ได้เฉพาะกรณี ร้ายแรง

เฉพาะเมื่อกระทำ ด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง คำนึงถึงความเป็นธรรม หักส่วนที่เป็นความบกพร่อง ของหน่วยงาน หรือระบบ และไม่ใช้หลัก ลูกหนี้ร่วม

ความหมายต่องานวัคซีน PCV

ผู้ให้วัคซีน ตามหน้าที่ ได้รับความคุ้มครอง ตาม ม.5 รวมเจ้าหน้าที่ราชการส่วนท้องถิ่น (ม.4) เช่น รพ.สต. ถ่ายโอน อบจ.

ปฏิบัติตาม คำแนะนำ กรมควบคุมโรค และบันทึกครบ ช่วยแสดงว่าไม่ประมาทร้ายแรง

ความบกพร่อง ของระบบ เช่น ขาดอัตรากำลัง หักออกจาก ความรับผิด

ข้อควรระวัง

ทำนอกหน้าที่ หรือนอกขอบเขต ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดเป็นการเฉพาะตัว

ฝ่าฝืนแนวทาง อย่างชัดแจ้ง อาจถูกพิจารณาว่า ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง

สรุปสั้น · สแกน QR เพื่อเปิดเอกสารต้นฉบับ

ทำตามหน้าที่ และแนวทาง หน่วยงานรัฐรับผิดแทน เจ้าหน้าที่รับผิดเฉพาะกรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯ 2539

แนวทางมาตรฐาน กรมควบคุมโรค และ WHO

คำแนะนำการให้บริการวัคซีน PCV และเด็กที่มารับบริการล่าช้า (NIP) ต.ค. 2569 · WHO position paper ก.ย. 2025

ตรวจสอบตัวบท 9 พ.ย. 2569

สาระสำคัญของตัวบท

ตาราง 2p+1

ฉีด 2, 4 และ 12 เดือน พร้อมวัคซีน ตามแผนงานฯ

2 เดือน พร้อม DTwP-HB-Hib1 + IPV1 + Rota1 · 4 เดือน พร้อม DTwP-HB-Hib2 + IPV2 + Rota2 · 12 เดือน พร้อม LAJE1

ร่วมกัน Co-admin

ให้ PCV พร้อมวัคซีนอื่น ในวันเดียวกันได้

> “ฉีดวัคซีนคนละตำแหน่ง หากต้องฉีดในตำแหน่งใกล้กัน ควรเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 นิ้ว”

ล่าช้า Catch-up

นับเข็มต่อ ไม่ต้องเริ่มใหม่

ให้ทันที เมื่อครบระยะห่าง ขั้นต่ำ ไม่ต้องรอนัด และนัดพร้อมวัคซีนอื่น เพื่อลดจำนวนครั้ง ที่มารับบริการ และลดการพลาดโอกาส

ระยะห่าง ขั้นต่ำ

เริ่มก่อน 12 เดือน แนะนำห่าง 8 สัปดาห์ ลดได้ถึง 4 สัปดาห์

เริ่ม 12–23 เดือน ให้ 2 ครั้ง ห่าง ≥ 8 สัปดาห์ ไม่ต้องกระตุ้น · PCV10 (Pneumosil) ใช้ได้ 6 สัปดาห์ ถึงก่อนครบ 2 ปี

ความหมายต่องานวัคซีน PCV

- ยึดหลัก ให้เด็กได้ภูมิคุ้มกัน เร็วที่สุด และไม่พลาดโอกาส (Missed opportunity)
- กลุ่มเสี่ยงสูง ใช้สูตร 3p+1 (2, 4, 6 เดือน และกระตุ้น 12–15 เดือน) ปรึกษากุมารแพทย์
- บันทึก HIS → HDC และ MOPH PHR ให้ถูกต้อง

ข้อควรระวัง

- การเลื่อนเข็ม ที่ถึงกำหนดออกไป ไม่ใช่ตารางมาตรฐาน ทำให้เด็ก ขาดภูมิคุ้มกันนานขึ้น
- AEFI ที่พบ ปวด บวม แดง ส่วนใหญ่ไม่รุนแรง หายเองใน 2–3 วัน

สรุปสั้น · สแกน QR เพื่อเปิดเอกสารต้นฉบับ

ตารางมาตรฐานคือฉีดพร้อมวัคซีนตามวัยในนัดเดิม ฉีดคนละตำแหน่ง เด็กที่มาล่าช้าให้ทันทีเมื่อครบระยะห่างขั้นต่ำ

คำแนะนำ PCV กรมควบคุมโรค ต.ค. 2569